

THÔNG BÁO

**Kết luận cuộc họp tại Bệnh viện Từ Dũ Cơ Sở 2
ngày 13 tháng 01 năm 2026**

Ngày 13 tháng 01 năm 2026, BS CKII Trần Ngọc Hải – Giám đốc Bệnh viện đã chủ trì buổi họp với ban điều hành, các bộ phận/khoa của Bệnh viện Từ Dũ Cơ Sở 2

Sau khi các khoa/bộ phận báo cáo tiến độ thực hiện và trao đổi, thảo luận với đại diện các khoa, ban điều hành, BS CKII Trần Ngọc Hải – Giám đốc Bệnh viện có kết luận, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành trễ nhất trước ngày 20 tháng 01 năm 2026, như sau:

1. Đối với công tác Hành Chánh Quản Trị :

a. Ngoại cảnh:

- Đồng phục bảo vệ:

- + Thực hiện theo đồng phục CS1
- + Vải thoáng mát
- + P.TCCB + HCQT + Đ.Dưỡng: thiết kế nón cho bảo vệ (theo mẫu bộ quốc phòng), giày màu sẫm, dây lưng màu sẫm, trình Giám đốc trước 14.01.2026

- Bố trí đèn nội viện

- Khu vực vườn phía trước:

- + Không trồng nhiều loại cây
- + Quy hoạch khu vực cây cau: trồng xung quanh phòng khám. Lưu ý: không trồng chỗ để xe hơi, khoảng cách các cây cau bằng nhau.
- + Cây trồng mới, cây thẳng, không rẽ nhánh, thân không nhám (tham khảo cây Bằng lăng)
- + Vườn cây làm theo ô, tránh cỏ mọc.
- + Đo khoảng cách các cây đều nhau, gốc cây dùng gạch định để có thể bón phân cho cây
- + Quy hoạch cây trồng ở công viên phía trước: trồng cây hoa vàng, cây xoài

- Quy hoạch khu vực làm vườn thuốc nam

- Khe nứt tòa nhà: Xử lý các vết nứt ưu tiên mặt tiền tòa nhà

- Khu vực hành lang phía ngoài cấp cứu:

- + Đổ cát khu vực giữa hành lang và tòa nhà
- + Gia cố lại toàn bộ lan can trắng.
- + Hai khu vực cây trước cấp cứu trồng: cây Vạn Thiên Tuế
- + Quy hoạch lại cây khu vực xung quanh

- Trước khu C (lối đi từ cấp cứu qua): tỉa cây không để cao quá mái của tòa nhà

- Trước khu nhà G: quy hoạch các cây tại khu vực này

- Lối vào từ khu vực bình Oxi đến nhà ăn nhân viên: quy hoạch cây ở 2 dãy đường đi.

- Khu vườn phía trước nhà ăn nhân viên: trồng cây xoài, gốc Cẩn Giờ

- Khu vực vườn phía bên phải, kế kiểm soát nhiễm khuẩn: cải tạo lại vườn để Đoàn Thanh Niên xuống tăng gia sản xuất.

- Cải tạo hồ cá:
 - + Vòng ngoài trồng cây
 - + Vòng trong làm hồ có vòi phun nước
- Khu vực xe lăn:
 - + Xử lý xi măng lối lên để xe dễ di chuyển lên
 - + Khắc phục bất cập lối đi xe lăn từ phía lối vào chính (bậc tam cấp) trước phòng khám.

b. Công tác quản lý khác:

- Decal:

- + Làm biển báo: Nhà xe Nhân viên
- + Phòng điều hành: đổi lại kính sọc, không dán toàn bộ decal mờ
- + 2 cửa giữa khu cấp cứu và nhà vệ sinh tại cấp cứu: dán decal: Lối đi nhân viên y tế

- Công tác kiểm tra, giám sát:

- + Khóa các thang máy bệnh nhân không sử dụng. Thông báo nhân viên không sử dụng thang máy lên tầng 1, 2.
- + Rà soát và khóa các nhà vệ sinh ít hoặc không sử dụng.
- + Rà soát các vị trí rò rỉ nước.
- + Xem xét nguồn nước tưới cây thay cho nước thành phố, sử dụng hiệu quả nguồn lực.

- Camera: dùng loại wifi.

- Di dời tất cả giường tại khoa Cấp cứu thay bằng 5 ghế đa năng.
- Trang bị cửa kiên cố 5 vị trí (xác định ngày 06.01.2026) tại cấp cứu.
- Hệ thống cửa điện lối vào và tại khoa cấp cứu.
- Trang bị Face ID điểm danh giao ban các khoa tại khoa Cấp cứu
- Quản lý vị trí để xe hơi của nhân viên.
- Quản lý các đơn vị ngoài, Bs. Bảo Anh + anh Hữu kiểm soát chặt chẽ:
 - + Quy định chỗ để xe của 115 đúng quy định, không để trong nội viện
 - + Xe máy của đơn vị xây dựng dự án

- Quản lý điện, nước:

- + Giám sát mỗi ngày. Báo cáo những tăng giảm đột xuất
- + Báo cáo theo tuần cho BGD

2. Đối với công tác chuyên môn:

- Công tác giao ban, Ban giám đốc hoặc đại diện được ủy quyền của phòng KHTH:

- + Báo cáo giao ban bệnh viện: bổ sung Thư ký, người ghi trực tiếp Báo cáo giao ban bệnh viện
- + Báo cáo giao ban bệnh viện cần thể hiện chi tiết các ca chuyển viện cấp cứu; phần kết luận giao ban: cần có đầu việc triển khai, ai triển khai, khi nào hoàn thành.
- + Ths. Long có nhiệm vụ thông báo các công việc giám đốc yêu cầu triển khai trên giao ban và nội dung này phải ghi vào biên bản giao ban.

- + Giao ban chung các khoa: khoa Cấp cứu, phòng khám, GMHS, khoa ngoại, khoa nội, định kỳ hằng ngày tại phòng giao ban khoa Cấp Cứu. Gồm bác sĩ phụ trách và hộ sinh, điều dưỡng.
- P.KHTH :
 - + Giải trình việc khoa Nội chưa chuyển xuống cấp cứu trước 16.01.2026
 - + Bs. Bảo Anh, P.KHTH báo cáo Bs. Ngọc Hải về công tác thận nhân tạo trước ngày 15.01.2026
 - + Rà soát các ca bệnh lão về chỉ định Bilan đúng và đủ để tầm soát các bệnh liên quan.
 - + Phối hợp với Điều Dưỡng, Ths. Long hoàn thiện quy trình khám, in toa thuốc tập trung
 - + Báo cáo tuần: số lượng bệnh nhân tái khám, đặc biệt là khám thai và phụ khoa, số lượng bệnh nhân theo lịch tái khám nhưng không khám lại.
 - + Quy trình cấp cứu, quy trình chuyên môn
 - + Công tác chuyển tuyến: KHTH và Điều Dưỡng phối hợp giám sát việc chuyển tuyến (bệnh chuyển có nằm trong danh mục khám của bệnh viện không, nếu nằm trong danh mục thì lý do tại sao chuyển: năng lực, VTTBYT, cơ sở vật, thuốc)
- Bs. Trần Công Trường, khoa Cấp Cứu báo cáo lại các nội dung họp giao ban với Giám đốc ngày 06.01.2026.
- P.TCCB:
 - + Yêu cầu các nhân sự đợt trước phải xuống BVTD CS2 bàn giao lại, có biên bản với nhân sự mới, p.TCCB thu thập lại biên bản bàn giao báo cáo BGĐ thực hiện trước 16.01.2026
 - + Bố trí BS. KHTH trực tối
 - + Phối hợp KHTH, Điều dưỡng làm lịch trực, làm việc theo chuẩn của BVTD CS1 của các bộ phận (BS, Điều Dưỡng, HS, Công Xa, Bảo vệ,...)
 - + Xây dựng KPI hiệu suất phòng khám: tỉ lệ lượng bệnh nhân quay lại tái khám; KPI 5.000 bệnh khám đoàn sức khỏe vào Q1.2027
 - + P.TCCB làm việc với Bv Lê Văn Thịnh về thời gian làm việc để có thể giao ban khoa 15-20 phút vào cuối giờ chiều sau khi khám xong 16g mỗi ngày.
 - + P.TCCB lưu ý việc lựa chọn BS có khả năng giao tiếp và giữ bệnh nhân
 - + P.TCCB phối hợp với BV PHCN và YHCT , cử luân phiên nhân sự K.PHCN tại CS1 xuống học tập và đào tạo về PHCN và YHCT
- Công tác hành chính khoa cấp cứu: nhân sự khoa GMHS xuống phụ trách cùng cấp cứu. Cấp cứu đào tạo công tác cấp cứu đa khoa cho nhân sự GMHS.
- Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn:
 - + Xây dựng quy trình kiểm soát các khoa
 - + Xây dựng đường đi của các chất thải, dụng cụ, đồ dơ toàn viện
 - + P.TCCB mời bs Châu xuống khảo sát, gửi báo cáo cho BGĐ
 - + Kiểm soát nhiễm khu vực nhà rác

- + Kiểm soát công tác ăn tập trung, không ăn tại khu vực phòng khám, khu vực làm việc
- Khu vực bình Oxi : VTTBYT làm tờ trình để đảm bảo an toàn, vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn đúng quy định.
- Bố trí nhân sự trực Tết và nghỉ Tết tại phòng khám, nội trú, cấp cứu. Lưu ý, P.KHTH
 - + Điều dưỡng cần chuẩn bị khu vực khám bệnh tại khoa cấp cứu khi bệnh nhân có nhu cầu khám.
- Công tác Xét nghiệm:
 - + Báo cáo về các xét nghiệm thực hiện nhiều nhất tại bệnh viện từng tháng
 - + Báo cáo các xét nghiệm đưa về CS1 hoặc các đơn vị ngoài thực hiện
 - + Tờ trình đề xuất các xét nghiệm cần thiết trong danh mục và cần thiết để điều trị theo nhu cầu, mặt bệnh.

3. Đối với công tác quản lý:

- Đoàn Thanh Niên: phối hợp với HCQT vệ sinh + tăng gia sản xuất mỗi tháng.
 - Khoa Cấp cứu: trình bày phương án di dời phòng xử lý dụng cụ. Khoa KSNK kết hợp với CC xem lại quy trình xử lý dụng cụ.
 - Phòng khám:
 - + Khu vực tiếp nhận
 - + In toa tập trung triển khai toàn bộ phòng khám chiều thứ 3, 13.01.2026
- Phòng KHTH thông báo Kết luận của Giám đốc để các khoa phòng liên quan để biết và nghiêm túc thực hiện. 

GIÁM ĐỐC 

BS CKII Trần Ngọc Hải